

PROTOCOLO DE LA ATENCIÓN POR SITUACIONES DE SALUD MENTAL



del **equipo de Alertas** de
la **Secretaría Distrital de**
Integración Social

Subdirección para la Juventud

1

OBJETIVO

Brindar orientaciones técnicas a los/las profesionales psicosociales frente a las acciones a desarrollar en la implementación de los procesos operativos, administrativos y de seguimiento referidos por la activación de la alerta por Salud Mental en las y los adolescentes y jóvenes vinculadas a los servicios de la Subdirección para la Juventud.

2

MARCO CONCEPTUAL

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Salud Mental puede definirse como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones cotidianas de la vida, puede trabajar de forma productiva y eficaz y es capaz de hacer una contribución a la sociedad. La salud mental es un componente de bienestar integral y esencial de la salud, por lo que no se refiere exclusivamente a la ausencia de trastornos, sino que abarca el bienestar psicológico, físico y social, incluyendo el desarrollo humano, el ejercicio de derechos, la vida relacional y emocional y la capacidad de autogestión respecto a las obligaciones cotidianas (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022).

Salud Mental (SM):

Para Colombia según la ley 1616 de 2013, la Salud Mental es definida como *“un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad”* (MSPS, 2013).

Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.

Según la Política Distrital de Salud Mental (2022-2032), la salud mental se construye a través de las relaciones interpersonales, en contextos históricos, culturales, económicos y políticos, y puede verse afectada de forma negativa por diversos factores, tales como la edad, etnia, género, orientación sexual, situación socioeconómica, ser víctima del conflicto armado, condiciones de salud o discapacidad; así como situaciones, condiciones o posiciones de exclusión o vulneración de derechos, como la habitabilidad en calle, los flujos migratorios, entre otros.

Para comprender la salud mental, es fundamental entenderla desde una perspectiva multifactorial, en la cual los determinantes sociales de la salud juegan un papel decisivo. Según la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS (2008), estos determinantes son las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y están influenciadas por la distribución del poder, los recursos y las oportunidades. Factores como la pobreza, el acceso desigual a la educación y al empleo, la discriminación estructural, la inseguridad alimentaria, la violencia, el acceso limitado a servicios de salud de calidad y las condiciones de vivienda precaria impactan directamente en la salud mental de los individuos y comunidades. En este sentido, la salud mental no puede abordarse únicamente desde lo clínico, sino desde una mirada intersectorial que integre políticas públicas orientadas a mejorar estas condiciones estructurales, promoviendo el bienestar colectivo y la equidad social (OMS, 2008).

Según el estudio de Salud Mental de Bogotá (2023), una de las poblaciones más afectadas por problemas de salud mental es la juventud. Se encontró que las y los jóvenes presentan altos niveles de síntomas depresivos y de ansiedad generalizada, con una prevalencia significativa en comparación con otros grupos etarios. Además, se identificó que los adolescentes y los jóvenes también reportan con frecuencia ideas suicidas, lo que representa un importante indicador de alerta para la salud pública. Estas condiciones afectan tanto a hombres como a mujeres, con variaciones según la localidad y el entorno (urbano o rural). Asimismo, la pandemia por COVID-19 tuvo un impacto notable en esta población, pues muchos jóvenes manifestaron que su salud mental se vio bastante o muy afectada, y una proporción considerable indicó que no ha logrado recuperarse completamente de dichas afectaciones.

Para poder desarrollar este apartado, es importante tener en cuenta que la atención brindada por los servicios de la Subdirección para la Juventud va a abordar las situaciones de Salud Mental, en dos sentidos: 1. Atenciones a las y los adolescentes y jóvenes con situaciones de crisis emocionales presentadas en las instalaciones de los servicios o atendidas por vía telefónica. 2. Atenciones a jóvenes y adolescentes que realicen solicitud o reporte voluntario sobre necesidad de atención especializada por salud mental.

3

ATENCIÓN A ADOLESCENTES O JÓVENES EN CRISIS EMOCIONALES

Una situación de **crisis psicológica** se entiende como un estado temporal de alteración emocional, cognitiva y/o comportamental en el que el o la adolescente o joven no puede utilizar sus recursos personales para enfrentar una situación estresante, lo que puede derivar en conductas desadaptativas, riesgo para sí mismo o para otros (James & Gilliland, 2017).

Una de las alteraciones que más se presentan en la población adolescente y joven, es la **conducta suicida**, que en su definición más simple, se refiere a una serie de pensamientos y acciones que realiza una persona con la intención de poner fin a su vida. Este conjunto incluye desde la ideación suicida, la planificación, los intentos de suicidio y, en última instancia, el suicidio consumado (OMS, 2014). Por su lado, la **ideación suicida** hace referencia a los pensamientos que tiene una persona sobre acabar con su vida. Si bien, son conceptos relacionados, la ideación suicida se refiere exclusivamente a los pensamientos o deseos, sin que necesariamente haya una acción concreta relacionada; puede ser pasiva (como querer desaparecer) o activa (pensar en cómo suicidarse). En cambio, la conducta suicida implica una acción o comportamiento con la intención de morir, como planear el acto, hacer un intento o llevarlo a cabo. La principal diferencia es que la ideación está en el plano mental, mientras que la conducta incluye pasos reales hacia el suicidio.

Frente a estas situaciones, es necesario que el o la profesional tenga la capacidad de guiar a el o la adolescente o joven hacia la calma y que pueda orientar el proceso de búsqueda de ayuda profesional especializada, de acuerdo con la necesidad de intervención (urgente o no urgente). Es importante resaltar, que el presente protocolo pretende dar orientaciones generales, sin embargo, la atención de cada caso va a depender de las características particulares del mismo.

¿Cómo abordar el tema de Salud Mental en territorio?

Cuando se aborde un caso de salud mental, el o la profesional psicosocial deberá distinguir entre si la situación es urgente o no urgente. Se entenderán por “urgentes”, las situaciones donde se evidencie una alteración aguda que requiera una intervención inmediata para prevenir el daño a sí mismo o a otros, frente a las cuales será deber de el o la profesional llamar a la línea 123 para solicitar ayuda especializada y se entenderán por “no urgentes” las situaciones donde él o la adolescente o joven presenten una situación de crisis que pueda ser contenida por el o la profesional psicosocial, que no represente un riesgo aparente para su vida y que posteriormente pueda realizarse una remisión para una atención especializada a corto plazo. Para ambos casos, se recomienda acompañar a el o la adolescente o joven teniendo en cuenta los siguientes momentos.



Momento 1: Detección Inmediata

Se puede identificar un caso de alerta por salud mental, a través de dos vías: hallazgo en medio de una actividad regular del servicio por parte de la o el profesional psicosocial de algunos de los signos de alarma, o por medio del reporte por parte de la o el adolescente o joven, ya sea de manera presencial o por vía telefónica. A continuación se brindan las recomendaciones generales a tener en cuenta:

1. Identifique signos de alerta: llanto incontrolable, gritos, desconexión con la realidad, mención de alucinaciones (ver, escuchar, sentir algo que no existe), verbalización de ideas de muerte (querer morir), suicidio (quitase la vida por sus propios medios, estableciendo método y plan), autoagresión (hacerse daño) o heteroagresión (hacerle daño a otros), mutismo (ausencia de verbalización de palabras por un periodo prolongado o con ciertas temáticas de riesgo), descuido de aseo personal por varios días, aislamiento prolongado, dejar de ingerir alimentos por varios días, deterioro abrupto de la funcionalidad global (interacción social, desempeño académico).
2. Asegure el entorno en el que se encuentra el/la adolescente o joven en situaciones de riesgo de agitación o heteroagresión, con el objetivo de prevenir conductas que puedan poner en peligro su integridad física o la de otras personas presentes. Esta acción prioriza la seguridad como condición fundamental para brindar una intervención adecuada y efectiva.
3. Ubique a el o la adolescente o joven en un espacio seguro, tranquilo y privado, esto permitirá reducir los detonantes y estímulos aversivos. En caso de ser necesario proteja a el o la adolescente o joven y a las demás personas del entorno, retirando objetos peligrosos.



Momento 2: Contención emocional

Acérquese a el o la adolescente o joven utilizando técnicas de Primeros Auxilios Psicológicos buscando que vuelva a la calma.

1. Acérquese de forma empática, respetuosa y receptiva, usando un tono de voz suave y cálido. Póngase a la altura de la persona y háblele mirándola a los ojos de forma suave y calmada. En caso de no conocer a la o el adolescente o joven preséntese con su nombre e indique su profesión y su intención de ayudarlo/a en ese momento. Evite confrontaciones directas o emitir juicios, puede usar frases como: "Estoy aquí para ayudarte, ¿Puedo sentarme contigo?", "Te voy a acompañar, este es un lugar seguro".
2. Si el o la adolescente o joven presenta desregulación emocional, utilice estrategias como la respiración guiada de cinco segundos, respiración diafragmática, relajación muscular progresiva, entre otras. También puede utilizar la focalización sensorial, haciendo preguntas respecto a ¿Qué puedes ver, oír, tocar en este momento?, esto con el fin de ayudar a la o el adolescente o joven a regular la activación emocional del momento.
3. A partir de la respiración y a medida que observe que la activación de el o la adolescente o joven se reduce, introduzca preguntas referentes que permitan que el participante se ubique en el tiempo y espacio. Por ejemplo, ¿Cuál es tu nombre?, ¿Sabes qué día es hoy?, ¿Sientes frío o calor?, ¿Donde vives?, etc.
4. Cuando el o la adolescente o joven logre regular o reducir notablemente su malestar emocional, en la medida de lo posible, entable una conversación indagando respecto al nivel de afectación de la situación con el propósito de identificar si el o la adolescente o joven necesita una atención especializada urgente o no urgente.

Recomendaciones: Permita a el o la adolescente o joven expresarse sin ser interrumpido, es importante que el o la profesional psicosocial mantenga y transmita calma con una mirada suave, expresión amigable y un tono de voz apacible. Guarde una distancia prudente, no promueva la confrontación con preguntas insistentes o haga un interrogatorio. Evite llevar la contraria y el contacto físico a menos que sea necesario. Si bien es importante que determine el nivel de riesgo, no es necesario que aborde a profundidad la situaciones que detonó la crisis, **enfóquese en las necesidades de la o el adolescente o joven en el momento actual.**

4. Ante la presencia de ideación suicida, es fundamental que el o la profesional en psicosocial indague de manera directa y sin ambigüedades si la persona presenta una ideación suicida estructurada (con plan, medios y tiempo definidos) o no estructurada. Esta diferenciación permite establecer si se trata de un riesgo vital inminente, lo cual requiere remisión inmediata a atención especializada en salud mental.

Se recomienda a los profesionales psicosociales que, al abordar una posible conducta suicida, no eviten preguntar sobre ideas, planes y tiempos asociados a la acción suicida. Contrario al mito de que preguntar puede inducir al suicidio, esta indagación es una herramienta esencial para valorar el riesgo y proteger la vida de el o la adolescente o joven. Además, debe garantizarse un entorno de escucha empática, libre de juicios, y una articulación inmediata con los servicios de salud disponibles (líneas de atención en crisis, urgencias psiquiátricas o EPS, según el caso).



Momento 3: Respuesta inmediata y reporte

Antes de seguir con el reporte es necesario que brinde una respuesta inmediata que responda a la urgencia de la situación.

- A. Si la situación amenaza la integridad de la vida de el o la adolescente o joven o de otra persona debe llamar inmediatamente a la línea 123 para solicitar apoyo de la entidad Policial y por Salud mental. Finalizada la llamada, deberá contactar con el/la líder de alertas de su servicio y comunicar la situación presentada. Luego una vez controlada la situación deberá realizar el reporte en el formulario de alertas.
- B. Si identifica que no está en riesgo la vida del el o la adolescente o joven, pero que requiere una orientación psicológica, llame a la línea 106 y canalice a el o la adolescente o joven en la plataforma SIRC, para que la EPS atienda el caso.

Nota:

Es importante que la persona que activa la línea tenga algunos datos básicos de el o la adolescente o joven como: la ubicación, nombre, dirección y número de teléfono o de quien se encuentre con este. En lo posible el o la profesional psicosocial debe indagar si el o la adolescente o joven tiene algún antecedente importante en salud mental. Esto con el fin de brindar un contexto claro al profesional que recibe la llamada y así mismo dirigir la atención correcta al caso.

El o la profesional psicosocial que recibe el caso deberá registrar la situación en el formulario de alertas, incluyendo toda la información requerida. En el campo de observaciones, deberá realizar una descripción detallada que permita comprender de manera integral la situación reportada. El enlace de este formulario es de uso exclusivo de los psicosociales y profesionales del equipo de alertas, no deberá ser utilizado por otra persona sin autorización. Cada semana el líder de alertas de cada servicio recibirá el consolidado de alertas reportado por parte de analítica para continuar con el proceso de enrutamiento.



Momento 4: Enrutamiento

El enrutamiento de las alertas urgentes se realiza de forma inmediata. En el caso de las alertas no urgentes, el enrutamiento se realiza de manera semanal, a partir del consolidado enviado por el equipo de analítica. El enrutamiento por salud mental (ver Figura 1) se gestiona a través del reporte a la Secretaría Distrital de Salud, entidad competente para atender este tipo de situaciones. Para ello, se deben seguir los pasos que se describen a continuación.

- A.** Verificar si el o la adolescente o joven está afiliado a EPS mediante la consulta rápida en ADRES. <https://www.adres.gov.co/consulte-su-eps>. (Si el o la adolescente o joven no está vinculado se debe enviar y adelantar las acciones correspondientes al reporte de alerta "Personas sin aseguramiento en salud").
- B.** En caso de que el o la adolescente o joven muestre aún por sospecha, alguna conducta autolesiva o suicida, el o la profesional psicosocial deberá diligenciar el formato digital de SISVECOS, siguiendo las indicaciones de la ficha técnica, y deberá enviarlo por correo electrónico a él o la líder de alertas del servicio correspondiente, quien se encargará de cargarlo en el Sistema de Información de Vigilancia en Salud Pública. **Importante:** para todos los casos donde se reporte una situación de conducta o ideación suicida, será obligatorio la canalización por SIRC.
- C.** El o la profesional del equipo de alertas diligencia la ficha de canalización SIRC (Sistema de información referencia y contrareferencia), plataforma mediante la cual Secretaria de Salud, canaliza a la EPS correspondiente el caso de el o la adolescente o joven, con el propósito de brindar un atención oportuna. Una vez cargada la información en la plataforma, la EPS llamará a el o la adolescente o joven a programar una cita por psicología. Es importante que el o la profesional que atienda el caso, le informe a el o la adolescente o joven que va a ser llamada por la EPS para programar la cita, esto con el fin de favorecer el contacto telefónico y que se logre la canalización.

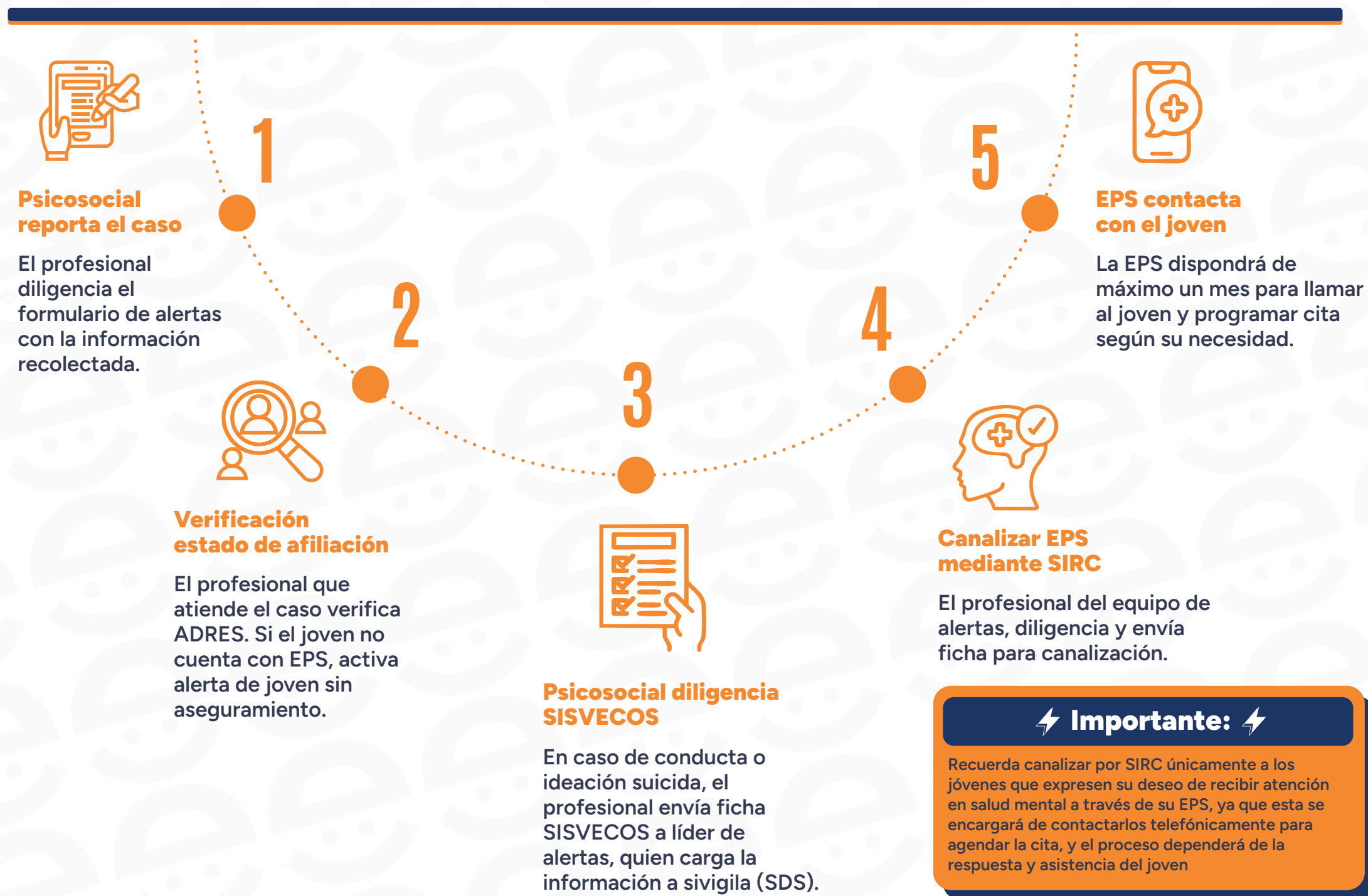


Figura 1. Proceso de enrutamiento para atención por Salud Mental

Momento 5: Seguimiento

El o la líder de alertas se comunicará con el psicosocial quien realizó el reporte con el fin de conocer el avance del caso. El primer seguimiento se realizará cinco días después de la creación de la alerta, posteriormente se realizarán seguimientos bimensuales por seis meses. Para los casos donde se realizó reporte en SISVECOS, será necesario verificar el estado del caso en el aplicativo del Sistema de Información de Vigilancia en Salud Pública en la sección del SISVECOS y realizar llamada telefónica para verificar información con el o la adolescente o joven. Los seguimientos se realizan según los tiempos de cada servicio.

El equipo de alertas, realizará mesas de seguimientos de casos con los líderes de alertas, coordinadores e instituciones según corresponda y se irá modificando el estado de la alerta según las convenciones establecidas en el drive de seguimientos. La actualización de tal documento estará a cargo de la/el líder de alertas de cada servicio.

4

ATENCIONES A ADOLESCENTES O JÓVENES QUIENES VOLUNTARIAMENTE SOLICITEN O REPORTEN NECESITAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA POR SALUD MENTAL

Para los casos donde los o las adolescentes y/o jóvenes de los servicios manifiestan a el o la profesional la necesidad de recibir atención especializada en salud mental o cuando se identifique en medio de alguna actividad o sala de escucha que un o una adolescente o joven requiere atención por psicología, se deberá activar la ruta de atención por salud mental, previamente descrita en el momento 4 del apartado anterior. En la infografía 2, se resume tal información.

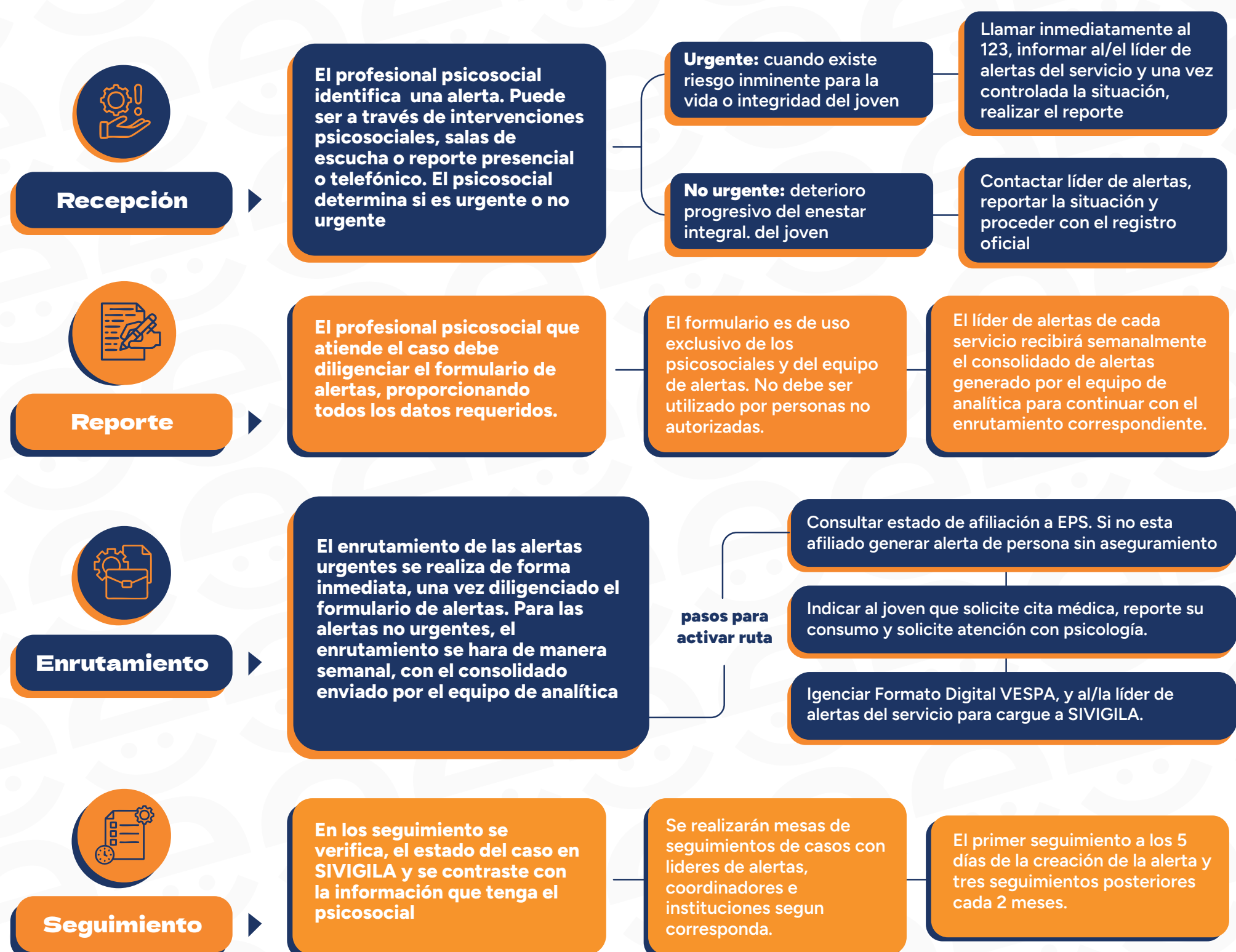


Figura 2. Flujograma activación de alerta por salud mental.



Recomendaciones generales

A continuación, se presentan algunas recomendaciones que podrán facilitar la atención a las y los adolescentes y jóvenes en temas de salud mental.

1. Escuchar activamente y sin juicios, prestando atención genuina, sin interrumpir ni minimizar sus emociones.
2. Crear un ambiente seguro y de confianza, garantizando un espacio privado, tranquilo y libre de críticas para la conversación.
3. Usar un lenguaje claro, respetuoso y apropiado para la edad, adaptando el vocabulario a su nivel de comprensión y evitando tecnicismos innecesarios.
4. Validar sus emociones y experiencias, haciéndole saber que lo que siente es importante y que buscar ayuda es valiente.
5. Garantizar la confidencialidad, salvo en situaciones de riesgo inminente, explicando claramente los límites de la confidencialidad desde el inicio.
6. Evaluar signos de riesgo (autolesiones, ideación suicida, consumo de sustancias, violencia) y nunca subestimar las alarmas.
7. Brindar orientación clara y opciones de ayuda, explicando los pasos a seguir, incluyendo remisión a otros servicios o entidades si es necesario.
8. Involucrar a la familia o redes de apoyo cuando sea adecuado y con consentimiento, promoviendo la contención afectiva sin vulnerar la autonomía de la o el adolescente o joven.
9. Respetar su identidad de género, orientación sexual y expresiones culturales, mostrando apertura e inclusión en todo momento.
10. Registrar adecuadamente la atención, documentando lo conversado y las decisiones tomadas con claridad y precisión dentro del formulario de alertas o en los documentos preestablecidos por el servicio correspondiente.



Lo que no se debe hacer

1. No minimizar, ignorar o invalidar lo que el o la adolescente o joven dice o siente, no usar frases como "eso no es para tanto" o "otros están peor" son perjudiciales.
2. No emitir juicios de valor ni sermonear, evitar actitudes moralistas o que culpen a el o la adolescente o joven por su situación.
3. No imponer decisiones sin su consentimiento informado, excepto en casos de riesgo vital, se debe respetar su autonomía.
4. No compartir información con terceros sin su permiso (salvo en casos de riesgo).
5. No usar etiquetas diagnósticas sin una evaluación adecuada, evita decir cosas como "eres depresivo" o "tienes ansiedad".
6. No forzar a el o la adolescente o joven a hablar si no está listo, también se puede acompañar en silencio.
7. No intervenir desde la prisa o sin preparación emocional, el profesional también debe estar en condiciones adecuadas para atender, si es necesario el profesional puede buscar apoyo en un compañero o en los líderes de alertas.
8. No dejar a el adolescente o joven sin seguimiento o sin una red de apoyo clara, siempre debe haber una ruta de atención definida después del primer contacto y el o la adolescente o joven debe saber que volverá a ser contactado.

Otros recursos

A continuación, encontrará algunas líneas de apoyo que podrán ser útiles en los procesos de atención con las y los adolescentes y jóvenes.

• Línea 106 “El poder de ser escuchado”

La Línea 106 “El poder de ser escuchado” es una Línea de ayuda, intervención psicosocial y/o soporte en crisis no presencial, atendida por un equipo de profesionales en psicología que brindan un espacio de escucha, orientación y apoyo emocional a toda la ciudadanía.

Entidad: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá

Población objeto: Habitantes de la ciudad de Bogotá de todas las edades.

Temáticas que atiende: Afectaciones de la salud mental, conducta suicida, violencias, consumo de sustancias psicoactivas, conflictos en las relaciones interpersonales.

Horario de atención: 24 horas al día, 7 días a la semana.

Canales de atención:

Chat de Whatsapp: 3007548933

Marcando de forma gratuita (desde un teléfono celular o fijo en Bogotá) el número 106

Escribir un correo electrónico al email:
linea106@saludcapital.gov.co

Facebook: @linea106

• Línea 123 Centro Regulator de Urgencias y Emergencias CRUE

El Centro Regulator de Urgencias y Emergencias - CRUE de la Secretaría Distrital de Salud, es la agencia en salud que recibe las solicitudes, casos e incidentes desde el Número Único de Seguridad y Emergencias – Línea 123, el CRUE es la agencia encargada de coordinar la atención y resolución de las urgencias médicas, las emergencias y los desastres del Distrito Capital a través del Sistema de Emergencias Médicas.

Entidad: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá

Población objeto: Toda la ciudadanía del Distrito Capital

Temáticas que atiende: Coordina la atención en eventos críticos en salud física, tales como accidentes cerebrovasculares (ACV), paros cardiorrespiratorios, partos extrahospitalarios, entre otros. En el ámbito de la salud mental, gestiona casos relacionados con pacientes con agitación, conductas hetero agresivas y autoagresivas, intentos de suicidio y situaciones de violencia, incluyendo maltrato físico, psicológico y violencia sexual.

Horario de atención: 24 horas al día, 7 días a la semana.

Canales de atención:

Marcando de forma gratuita (desde un teléfono celular o fijo en Bogotá) el número 123

• Línea Púrpura Distrital “Mujeres que escuchan mujeres”

Contribuye en la garantía de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias y a una salud plena. Presta un servicio post-emergencia a través de la atención psicosocial que incluye aspectos socio jurídicos, de forma telefónica y virtual. Es atendida por un equipo profesional interdisciplinario conformado por psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras. Posibilita una atención en primer nivel y la articulación con las diferentes estrategias y ofertas de servicio con las que cuenta la SDMujer. No es una línea de emergencia, ni de denuncia. Tampoco es la Patrulla Púrpura, está pertenece a la Policía Metropolitana de Bogotá.

Entidad: Secretaría Distrital de la Mujer

Población objeto: Mujeres mayores de 18 años que habiten la ciudad de Bogotá víctimas de violencias basadas en género o ciudadanía que conozca esas situaciones.

Temáticas que atiende: Violencias contra las mujeres con ocurrencia en el espacio público y/o privado, así como malestares de salud asociado a estos hechos. Derecho a la salud, con énfasis en los derechos sexuales y derechos reproductivos (métodos de anticoncepción e interrupción voluntaria del embarazo).

Horario de atención: 24 horas, todos los días del año.

Canales de atención:

Atención telefónica:
018000 112 137 (línea gratuita)

Chat de Whatsapp: 300 755 18 46

Video llamada, atendido por una agente profesional con dominio en lengua de señas colombiana (LSC):
<https://www.sdmujer.gov.co/nuestros-servicios/servicios-para-las-mujeres/linea-purpura>

Canal video llamada:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

• Línea Salva Vidas Fundación Sergio Urrego

Es la primera Línea de contención emocional en Colombia que brinda apoyo psicológico de forma gratuita; orienta y brinda herramientas sobre rutas de atención con otras instituciones, desde un enfoque basado en la defensa de los Derechos Humanos y la Acción sin Daño.

Entidad: Fundación Sergio Urrego

Población objeto: Niños, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sus familias y cuidadores.

Temáticas que atiende: Situaciones de riesgo asociadas a discriminación, conductas suicidas, violencia de género e intrafamiliar, y situaciones de movilidad humana en contextos de emergencia y aislamiento.

Horario de atención:
Lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.
Sábado 08:00 a.m. – 06:00 p.m.

Canales de atención:

Llamada telefónica y Chat de Whatsapp:
3117668666

Correo electrónico:
hablamoscontigo@sergiourrego.org

Redes sociales: @fundaciónsergiourrego

• Línea de ayuda - Te Guío

Línea de ayuda sobre conductas sexuales perjudiciales en niñas, niños y adolescentes. Conductas que son ajenas a la etapa de desarrollo, son anormales en términos de frecuencia o lugar en el que se realizan y representan un daño para quien las comete u otros.

Entidad: Secretaría Corporación Colombiana de Padres y Madres - Red PaPaz

Población objeto: Padres, madres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes.

Temáticas que atiende: Conductas sexuales perjudiciales.

Horario de atención:
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Canales de atención:

Chat de Whatsapp: 314 8210435

Línea telefónica: 01 800 519 0690

Página web: www.teguiocolombia.org

Instagram y Facebook: [teguio.viguia](https://www.instagram.com/teguio.viguia)

Twitter: [TeGuio_Viguia](https://twitter.com/TeGuio_Viguia)

• Línea de reporte - Te Protejo

Línea virtual de reporte de situaciones que amenazan o vulneran los derechos de la niñez y la adolescencia en Colombia. Miembro de INHOPE, que permite la articulación de líneas dedicadas a la eliminación de contenidos ilegales en Internet.

Entidad: Secretaría Corporación Colombiana de Padres y Madres - Red PaPaz

Población objeto: Público general (Niños, niñas, adolescentes, adultos).

Temáticas que atiende:

- Material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes
- Explotación sexual comercial (ESCNNA)
- Ciberacoso
- Convivencia escolar
- Tratos crueles, humillantes y degradantes
- Venta de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas
- Otras situaciones

Horario de atención: 24 horas al día, 7 días a la semana.

Canales de atención:

Página web: www.teprotejocolombia.org

Aplicación oficial: App Te Protejo

REFERENCIAS

James, R. K., & Gilliland, B. E. (2017). Crisis intervention strategies (8th ed.). Cengage Learning.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (s.f.). Protocolo de intervención en crisis para servicios de restablecimiento en administración de justicia [Versión 1].

https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/pt1.p_protocolo_intervencion_en_crisis_para_servicios_de_restablecimiento_en_administracion_de_justicia_v1.pdf

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2023). Anexo técnico de salud mental “Hablar lo cura”.

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/documentos-construccion/09._anexo_tecnico_de_salud_mental_hablar_lo_cura.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). Protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial a víctimas del conflicto armado – PAPSIVI.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/ride/de/ps/Protocolo-de-atencion-integral-en-salud-papsivi.pdf>

Pontificia Universidad Javeriana. (2020). Guía para acompañar y contener una crisis emocional en niños, niñas, adolescentes o jóvenes.

https://www.javeriana.edu.co/enmental/wp-content/uploads/2024/12/58-Protocolo-de-atencion-inmediata-en-crisis-mocionales_V3.pdf

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – Oficina Regional para los Países Andinos. (2024, mayo). Tomo 1 – Informe Ejecutivo del Estudio de Salud Mental en Bogotá 2023 [PDF]. Recuperado de

https://www.unodc.org/rocol/uploads/documents/2024/Descargas/mayo/Tomo_1_-_Informe_ejecutivo_ESMBOG_2023_Digital.pdf

Universidad EAN. (s.f.). Protocolo para el manejo psicológico a casos de crisis.

<https://universidadean.edu.co/sites/default/files/protocolos/PROTOCOLOPARAELMANEJOPSICOLOGICOACASOSDECRISIS.pdf>



¡Gracias!

**Distrito
Joven**



SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

